

消化器症状:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ 持ち帰りの制吐薬(デキサメタゾン等)の服用日を具体的に説明
- ☐ 止瀉薬・含嗽薬・下剤の使い方と受診の目安を伝える
- ☐ 電話フォローで遅発性悪心・下痢・口内炎を確認
- ☐ 症状をGradeで記録し、トレーシングレポートで強化を提案
- ☐ 市販の下痢止め・胃腸薬の自己判断での使用を確認

病院薬剤師

- ☐ 催吐性リスクに応じた制吐薬の設定・レジメン監査
- ☐ 投与日の制吐薬と、持ち帰りの制吐薬の処方設計
- ☐ イリノテカンのUGT1A1確認、早発性下痢への備え
- ☐ 外来化学療法室での制吐薬・止瀉薬の使い方の説明
- ☐ 前回の症状を評価し、次コースで制吐薬を強化

病院と共有する情報

レジメン名・催吐性リスク

持ち帰りの制吐薬

悪心・下痢のGrade

食事量・体重

2 重症度(CTCAE Grade)と保険薬局での対応の目安

Grade	下痢(ふだんとの比較)	口内炎	保険薬局での対応の目安
Grade1	排便回数が1日4回未満の増加	症状がない、または軽度	セルフケアを支援(止瀉薬・含嗽・保湿の使い方)
Grade2	1日4～6回の増加	中等度の痛み。食事の工夫が必要	処方医・病院へ連絡し、休薬・減量の判断につなげる
Grade3	1日7回以上、失禁、入院が必要	高度の痛み。経口摂取が困難	至急の受診を勧める(夜間・休日の連絡先を案内)
Grade4	生命を脅かす	生命を脅かす	救急受診

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌	オランザピン 血糖上昇作用	既往・疾患 糖尿病(他院で治療中の場合も)	高血糖・糖尿病性ケトアシドーシス	お薬手帳で糖尿病治療薬の有無を確認
注意	アブレピタント CYP3A4阻害	処方薬 デキサメタゾン	デキサメタゾン濃度↑	デキサメタゾンは減量して使用(用量を確認)
注意	アブレピタント CYP2C9・3A4誘導	処方薬 ワルファリン・経口避妊薬	INR↓・避妊効果↓	INRを確認、他の避妊法の併用を説明
注意	オンダンセトロン等 QT延長の重複	処方薬 抗不整脈薬・マクロライド系等	QT延長・不整脈	併用薬と低K・低Mg血症の有無を確認
確認	止瀉薬(ロペラミド) 症状を隠す	市販薬 市販の下痢止め(ICI大腸炎・感染性腸炎が疑われる時)	診断・治療の遅れ	自己判断で使わず、まず連絡するよう指導
確認	5-HT3受容体拮抗薬・オピオイド 便秘作用の重複	市販薬 市販の刺激性下剤	便秘の遷延・下剤の過量	下剤の処方と市販薬の使用状況を確認

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「吐き気止めは、吐き気がなくても決められた時間に飲みます。いつ何を飲むか、紙に書いてお渡ししますね」

確認:お薬手帳でレジメンの催吐性リスク、他院での糖尿病治療(オランザピン)

⚠ 前回つらかった方は予期性悪心の対策を相談

投与当日～5日

「2～5日目の吐き気にも備えましょう。水分は少しずつ、下痢が続く時は下痢止めを指示とおりに」

確認:電話フォローで遅発性の悪心・水分量・下痢の回数を確認

⚠ 水分がとれない・1日7回以上の下痢は至急連絡

投与後1～2週

「やわらかい歯ブラシで口の中を清潔に。うがいは食後と寝る前に、こまめにしましょう」

確認:口内炎の痛みと食事への影響、含嗽薬・保湿剤の使い方

⚠ 痛みで食事や水分がとれない時は連絡

次回来局時

「前回の吐き気や下痢は怎么样了か。一番つらかった日と、何回くらいだったか教えてください」

確認:悪心・下痢・口内炎をGradeで記録、体重・便秘の有無

⚠ Grade2以上はトレーシングレポートで制吐薬等の強化を提案